

中医二羊：伤寒论六经辨证小结

原创 二羊 养阳医斋 2019年10月17日 22:42

大家好，我是中医二羊，上一篇跟大家总结了八纲，八纲辨证具体内容，今天在总结以下六经。

提示：本篇属专业文章，为了不浪费你的时间。读过伤寒论的盆友可参考，临床同仁请多多分享交流你的经验，键盘侠可绕道。

学伤寒论的人总会有这样的问题，到底什么是六经，六经辨证中的太阳、少阳病等到底是什么意思？

六经是经络吗？跟经络有什么关系？关于这些理论的解读有很多，我这里仅提供我认同的和我的观点。仅供参考，我不能代表对错，不喜可绕道。



我总结自己的一点看法，分享给大家参考。

六经概念

伤寒论论原文中没有“六经”这一词，是后人总结的，六经是六经辨证。

具体是太阳、阳明、少阳的三阳，和少阴、太阴、厥阴的三阴病。

《伤寒论》用六经病来分类。

按上一篇中总结的阴阳虚实表里整合在一起，便得出以下结论：

六 经	八 纲	
	病位	病情
太阳病	表	阳
阳明病	里	阳
少阳病	半表半里	阳
太阴病	里	阴
少阴病	表	阴
厥阴病	半表半里	阴

第一个结论：经方家胡希恕说六经其实八纲的概括，六经的实质是八纲。我比较赞同这一观点。

六经是经络吗？

假如六经是经络的话，六经辨证就是六种经络辨证，那在开篇就说不通，好比太阳病有许多外症例如鼻塞流鼻涕、怕冷、甚至咳嗽，这些明明是手太阴肺经的症状，为什么把它归纳在太阳病篇呢？

如果六经不是经络的话，那少阳病篇许多症状口苦、头晕、胁肋痛等又是肝胆经的症状。

所以很多人在这里争论不休，其实在我看来没必要争论。

六经中有经络也有不是经络的症，为何这样说呢？因为我的观点是这样的

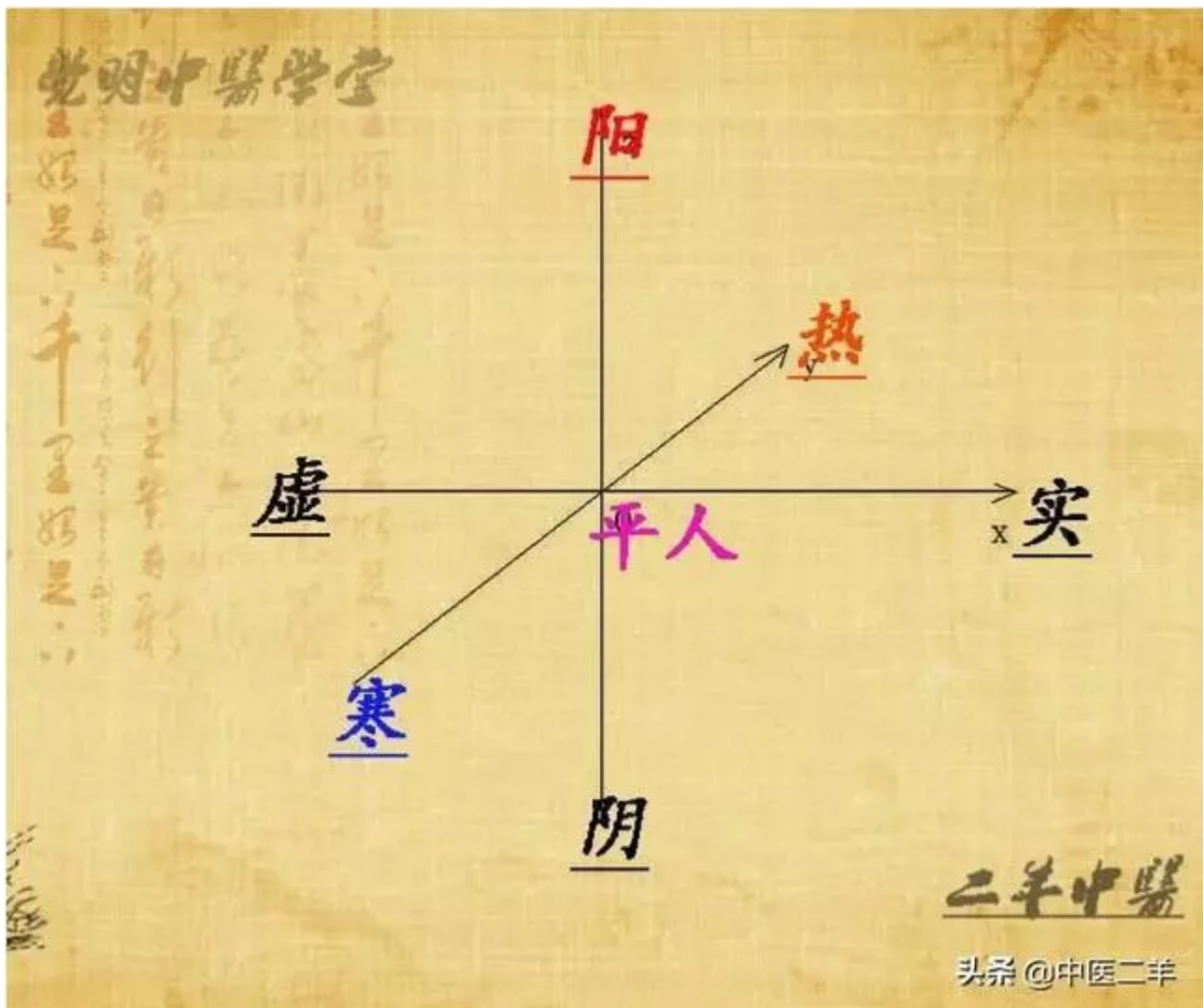
六经是六气吗？

解释伤寒论的有一个派别，用五运六气来解释伤寒论，我很佩服这方面的天才，可以把这些复杂的理论自圆其说的来解释伤寒论。还有一些易经数术派的。

但是，翻烂了伤寒论我是没有发现半点线索，估计张仲景先师表示我的脑洞没有那么复杂。伤寒论原文是很直白的，但后世医家越解释越复杂，尤其是那些脱离临床的理论。

假如你的理论解释的通，如果是真实的，那临床一定很好用。但是这方面的医家和临床经验好像很少很少，说起来好听，用起来难啊。实践才是检验真理的标准。

如果我们自己去读伤寒论，去读黄帝内经却是真真切切的，真实不虚的。



第二结论：二羊的观点，六经是人这个整体跟疾病斗争，正邪斗争所呈现出来的状态的归纳总结。

人是一个整体，包括躯干、脏腑经络、气血阴阳、精津液等，当人生病的时候这些都需要参与进来，只是看病情病势，病位有所侧重罢了。经络自然也会有，但不是全部，人才是

全部。

伤寒论跟黄帝内经是两个完全不通的派别吗？

有一部分医家说伤寒论是独立的体系，跟黄帝内经完全不同，连经方家胡希恕也这样认为，但是我们看他的书看他的结论，他也不是说八纲辨证吗？阴阳表里寒热虚实这些理论不就是黄帝内经里的嘛。

什么不能用黄帝内经的理论来解释伤寒论？

那你解释一个看看？连胡希恕老先生那么嘴硬的都还是要用内经的理论。

伤寒论是一本临床专著，讲治病，也讲人。黄帝内经就是一本总结人体生理和自然规律的基础医学书。

第三个结论：学好黄帝内对于帮助我们好伤寒论经方，我觉得是只有好处，没有坏处。

伤寒论脱离不了黄帝内经。

六经的临床应用

分享完我的三个观点，接下来看具体六经怎么应用的。

一个生了病的人，最终还是人。是一个整体，人跟病斗争过程中呈现出来的症状是最直观的，由症状总结规律来治疗也是最直接的。所以，方证对应可以帮助很多人可以很快上手伤寒论和经方。

但我们还得往里深究一点，病之见于证，必有病位，病性质。八纲比较抽象，更像一个方向，是一个大原则，而六经就很具体，更接地气，所以临床应用指导直接用药的还是六经。

太阳病

概念--第1条“太阳之为病，脉浮，头项强痛而恶寒。”

太阳病，即表阳证，以脉浮、头项强痛而恶寒等一系列的外在证候为特征的，也可以说，无论什么病，如果有太阳病的证候，都可以考虑有太阳病。前提是具体的临床证候证候为据。

不是以太阳经经络分布为根据。

阳明病

第180条：“阳明之为病，胃家实是也。”

阳明病，即里阳证。胃家实，指病邪充实于胃肠之里，实证，按下去硬满，而有抵抗和压痛等。胃家实为阳明病的特征，故凡病胃家实者，即可确断为阳明病。

阳明病气分证可见肺热症状

少阳病

第263条：“少阳之为病，口苦、咽干、目眩也。”

少阳病，即半表半里的阳证，它是以口苦、咽干、目眩等系列证候为特征，凡病见此特征者，即可确断为少阳病。

但是，口苦、咽干、目眩，不仅仅是肝胆病的部分症状，但做为半表半里阳证，也可以见于咽炎、肺炎、胃肠炎等急慢性病常出现此类证候。

太阴病

第273条：“太阴之为病，腹满而吐，食不下，自利益甚，时腹自痛，若下之，必胸下结硬。”

太阴病，即里阴证。它是以腹满而吐、食不下、自利益甚、时腹自痛等一系列的证候，凡病见此特征者，即可确断为太阴病。此腹满为虚满，需要跟阳明病的胃家实满鉴别。

少阴病

第281条：“少阴之为病，脉微细，但欲寐也。”

少阴病，即表阴证。跟太阳病病性相反，如果太阳病的症状，但是脉微细，并其人但欲寐者，可确断为少阴病。

厥阴病

第326条：“厥阴之为病，消渴，气上撞心，心中痛热，饥而不欲食，食则吐蛔，下之利不止。”

厥阴病，即半表半里阴证。它是以消渴、气上撞心、心中疼热、饥而不欲食、食则吐蛔等

一系列证候。凡病见此特征者，即可确断为厥阴病。

凡是半表半里证，无论阴证还是阳证，都不可下，尤其是阴证更不可下，若不慎而误下之，则必致下利不止之祸。

六经传变

六经是人跟病的状态状态体系，主要核心在于正气和邪气的盛衰。随时实在运动和变化的，传变也很快。可以渐变，也可以跳跃传变，可以表里相传。

阴证阳证也都可以瞬间转变。

并病和合病

并病-病当表里相传时，前边的还没好又传到后边了，同时两经病还在，叫并病。如太阳、阳明并病，少阳、阳明并病等均属之。

合病-初发病时，二者或三者同时出现，有似合在一起而发病，故谓为合病。如太阳、阳明合病，三阳合病等均属之。

不管怎么样，二羊觉得治疗手段是差不多的，就是根据目前的状态来处方。所以二者临床区别不大。



六经治病的大法则

通过六经八纲辨证后的治疗方向合原则。

表证-解表

太阳病：由于病在表，宜发汗，不可吐、下，如桂枝汤、麻黄汤、葛根汤等，均属太阳病的发汗法剂。

少阴病：此与太阳病均属表证而宜汗解，但发汗必须配伍附子、细辛等温性亢奋药，如桂枝加附子汤、麻黄附子甘草汤、麻黄附子细辛汤等，均属少阴病的发汗法剂。

里证-清里/温里

阳明病：热结于里而胃家实者，宜下之；但热而不实者，宜清热。下剂如承气汤，清热如白虎汤。若胸中实者，则宜吐，不可下，吐剂如瓜蒂散。

太阴病：里虚且寒，只宜温补，汗、下、吐均当禁用。如理中汤、四逆汤等，均属太阴病的温补法剂。

半表半里-和法

少阳病：半表半里证，法宜和解，汗、吐、下均非所宜。如柴胡汤、黄芩汤等，均属少阳病的解热和剂。

厥阴病：此虽亦属半表半里证时宜和解，但须和之以温性强壮药。如当归四逆汤、乌梅丸等均属之。

寒热虚实治疗原则

寒者热之，热者寒之：

寒者热之者，谓寒证，治宜温热药以驱其寒，如以干姜、附子、乌头等之配剂，均属温热驱寒药；

热者寒之者，谓热证，治宜寒凉药以除其热，如以栀子、黄芩、黄连、石膏等之配剂，均属寒凉除热药。

虚者补之，实者攻之：

虚者补之者，谓虚证，宜用强壮药以补益其不足，汗、吐、下等法均当严禁，如炙甘草汤、建中汤、肾气丸等，均属补虚剂。实者攻之者，谓实证宜以汗、吐、下等法彻底攻除其病邪，如麻黄汤、承气汤等，均属攻实剂。

本篇就总结到这里，学习伤寒论的其他总结，留意二羊后续文章。

附：我自己学习时总结的笔记分享出来，我不喜欢跟夸夸其谈者扯中医理论嘴皮帐，没有共同认识的基础。如果对我观点有不认同请多多海涵。

我借道路过罢了

中医是一种爱好，一种态度，也是一种生活。



如果对你有帮助，欢迎分享

中医二羊

广州中医药大学中医硕士，主导针药并治的大中医观，一个推崇经典古中医的80后中医。

一个铁杆中医脑残粉。有一味赤色梔子心，胸怀山中药，愿为熊胆使君子，继四圣岐黄之术。

长按指纹
一键关注



微信号: 养阳医斋



微信ID: yytcm100



二羊

“ 码字不易，感谢支持 ”

👍 喜欢作者

伤寒论学习、应用、体会 · 目录

◀ 上一篇

二羊再读伤寒论，八纲辨证整理和思考，临床意义比较大

下一篇 ▶

中医二羊，伤寒论笔记之麻黄类方总结

